

ADHERENCIA

Ficha del conjunto de datos de pacientes con tratamiento crónico

Referencia SRS / FAR / 2026 • Ficha de conjunto de datos

Conjunto de datos. 8 700 registros • 16 campos • cada registro corresponde a un paciente con tratamiento crónico prescrito • documento de circulación interna.

Este documento recopila, sin análisis ni interpretación alguna, el material descriptivo de un conjunto de datos de pacientes con tratamiento crónico prescrito en un servicio regional de salud. Se ofrece el diccionario de variables, las tablas de estadísticos descriptivos y una selección de representaciones gráficas, tal y como se obtendrían de una primera exploración del fichero. La lectura, el diagnóstico de la calidad del dato y cualquier conclusión quedan enteramente a cargo del analista. Los importes se expresan en euros mensuales y la adherencia se calcula sobre los envases efectivamente retirados en farmacia.

1 Diccionario de variables

La tabla siguiente enumera los campos del fichero con su definición desde el punto de vista del negocio. No se indica su naturaleza estadística ni el papel que cada uno pueda desempeñar en un análisis posterior.

Campo	Definición de negocio
patologia	Patología crónica que motiva el tratamiento.
farmacos_prescritos	Número de principios activos prescritos de forma crónica al paciente.
tomas_diarias	Número de tomas diarias que exige la pauta prescrita. El dato procede del registro operativo y no se somete a revisión manual.
adherente	Indica si el paciente retiró en farmacia al menos el ochenta por ciento de los envases prescritos en el periodo.
via_administracion	Vía de administración del fármaco principal del tratamiento.
vive_solo	Indica si el paciente vive solo en su domicilio.
revision_programada	Indica si el paciente tiene revisión periódica programada en atención primaria. El dato procede del registro operativo y no se somete a revisión manual.
copago_mensual_eur	Importe mensual que el paciente abona en concepto de aportación farmacéutica.
edad	Edad del paciente.
sexo	Sexo registrado en la historia clínica.
anios_diagnostico	Años transcurridos desde el diagnóstico de la patología principal.
nivel_estudios	Nivel de estudios máximo del paciente.
distancia_farmacia_km	Distancia entre el domicilio y la farmacia habitual.
area_sanitaria	Área sanitaria de adscripción del paciente. Se vuelca del sistema de gestión en la misma carga que el resto del fichero.
receta_electronica	Indica si el tratamiento está prescrito en receta electrónica.

Campo	Definición de negocio
fecha_corte	Fecha de corte del fichero de dispensaciones. Se consolida con periodicidad mensual junto con los demás campos.

2 Estadísticos descriptivos de las variables numéricas

Se recogen, para cada campo cuantitativo, el número de registros observados, el de ausencias, la media, la desviación típica, el mínimo, los cuartiles y el máximo.

Variable	<i>n</i>	Aus.	Media	D.T.	Mín.	Q1	Mediana	Q3	Máx.
Fármacos prescritos	8 700	0	3,98	3,39	0,00	1,00	3,00	6,00	32,00
Tomas diarias	8 700	0	2,37	1,10	1,00	2,00	2,00	3,00	5,00
Edad (años)	8 700	0	63,80	13,81	25,00	54,00	64,00	73,00	96,00
Años desde el diagnóstico	8 700	0	7,94	5,54	0,10	3,80	6,70	10,70	52,60
Distancia a la farmacia (km)	8 700	0	1,64	1,76	0,03	0,59	1,09	2,03	24,01

3 Distribución de frecuencias de las variables categóricas

Para cada campo cualitativo se indica el número de categorías distintas, las ausencias, la categoría más frecuente y su peso relativo.

Variable	Categorías	Aus.	Categoría más frecuente	Frec.
Patología crónica principal	16	0	hipertensión	1 844 (21,2 %)
Adherencia al tratamiento	2	0	si	4 985 (57,3 %)
Vía de administración principal	4	0	oral	5 771 (66,3 %)
Vive solo	2	0	no	6 455 (74,2 %)
Revisión programada en primaria	2	0	sí	4 682 (53,8 %)
Copago mensual (€)	2 427	0	4,51 €	14 (0,2 %)
Sexo	2	0	mujer	4 560 (52,4 %)
Nivel de estudios	5	0	primarios	2 980 (34,3 %)
Área sanitaria	8	0	área 3	1 134 (13,0 %)
Receta electrónica	2	0	sí	7 686 (88,3 %)
Fecha de corte	15	0	04/07/2025	619 (7,1 %)

El reparto completo de las dos variables cualitativas con mayor número de categorías se detalla a continuación.

Patología crónica principal	<i>n</i>	%
hipertensión	1 844	21,2
diabetes	1 691	19,4
dislipemia	1 356	15,6
asma	1 119	12,9
epoc	711	8,2
hipertension	282	3,2
hipertensión	272	3,1
HIPERTENSIÓN	247	2,8
DIABETES	207	2,4
diabetes	199	2,3
dislipemia	178	2,0
DISLIPEMIA	173	2,0
ASMA	130	1,5
asma	115	1,3
EPOC	92	1,1
epoc	84	1,0
Total	8 700	100,0

Fecha de corte	<i>n</i>	%
04/07/2025	619	7,1
06/07/2025	605	7,0
03/07/2025	601	6,9
08/07/2025	598	6,9
11/07/2025	594	6,8
09/07/2025	592	6,8
12/07/2025	592	6,8
13/07/2025	577	6,6
07/07/2025	567	6,5
05/07/2025	567	6,5
01/07/2025	564	6,5
14/07/2025	561	6,4
10/07/2025	556	6,4
02/07/2025	555	6,4
30/06/2025	552	6,3
Total	8 700	100,0

4 Representaciones gráficas

Las figuras que siguen se presentan sin comentario. Su pie se limita a identificar las variables representadas.

Matriz de correlación lineal entre las variables numéricas

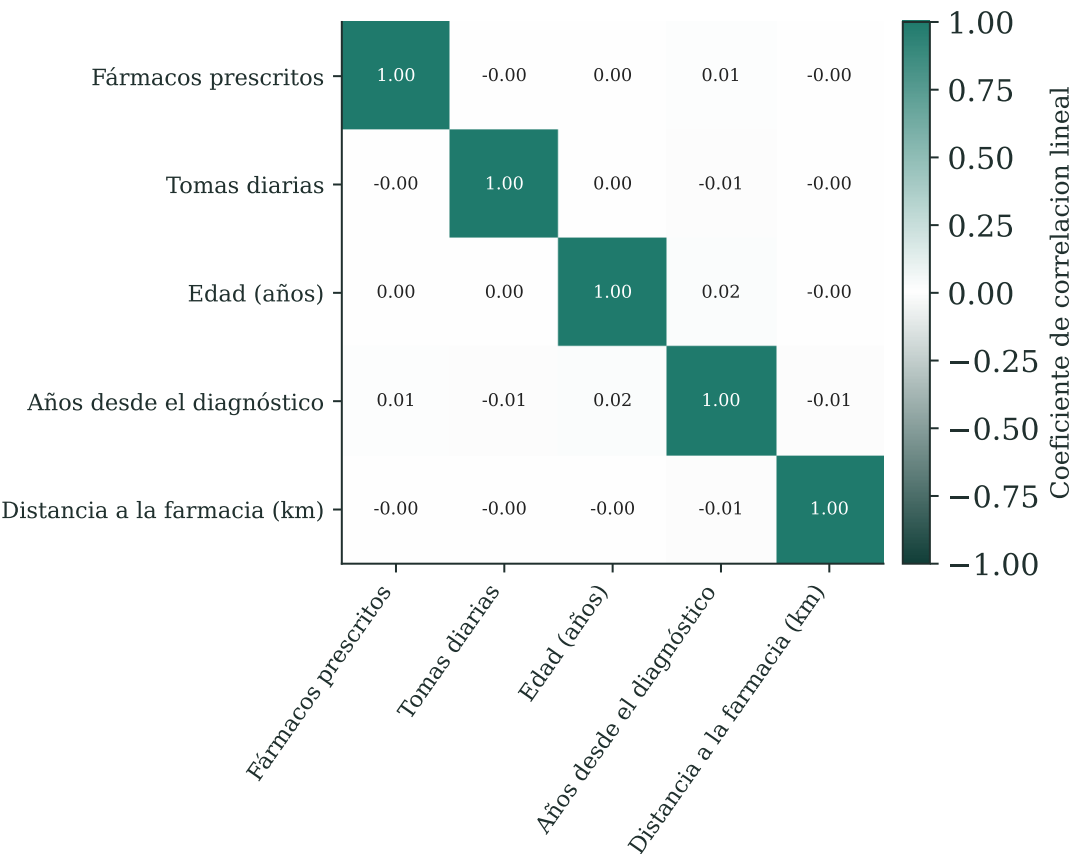


Figura 1. Matriz de correlación lineal entre las variables numéricas del conjunto.

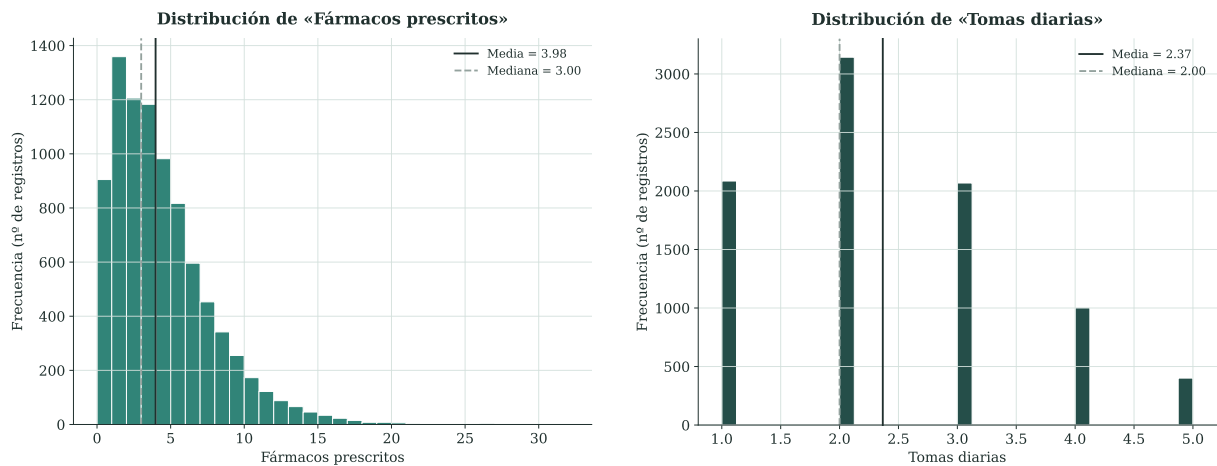


Figura 2. Distribución de «Fármacos prescritos» (izquierda) y de «Tomas diarias» (derecha).

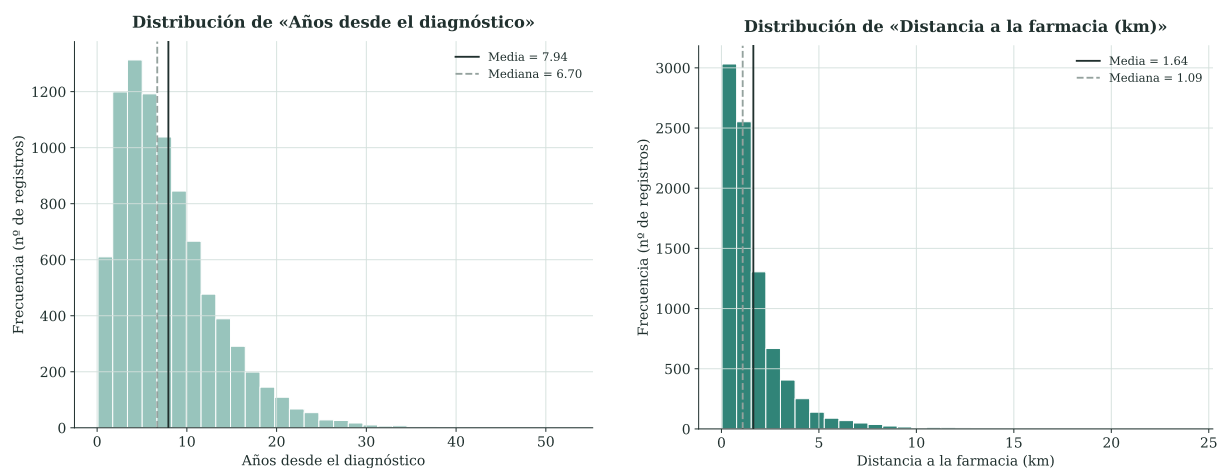


Figura 3. Distribución de «Años desde el diagnóstico» (izquierda) y de «Distancia a la farmacia (km)» (derecha).

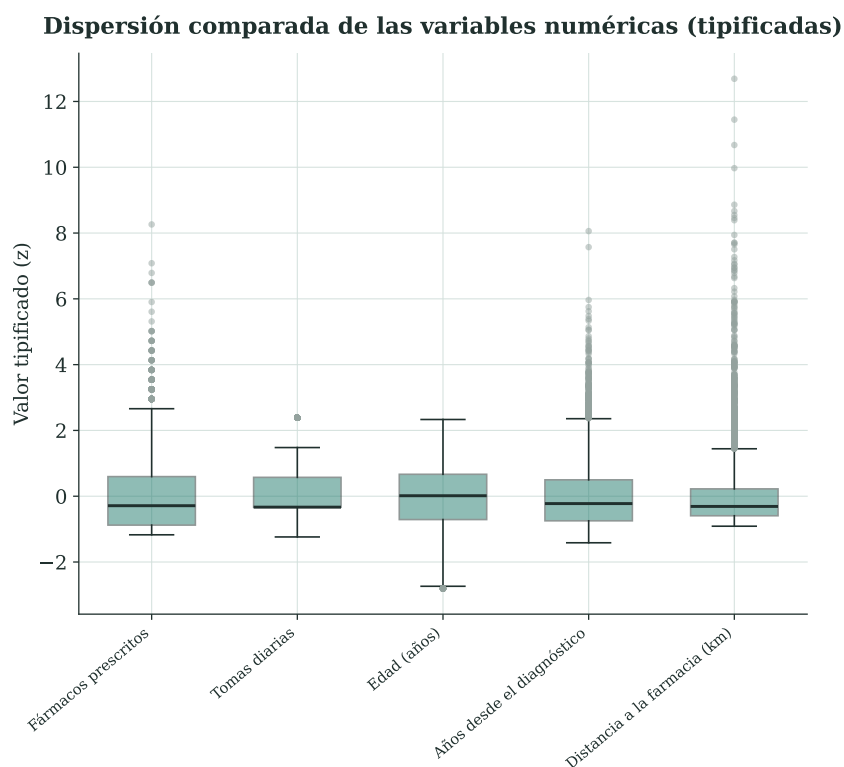


Figura 4. Diagramas de caja de las variables numéricas tipificadas, es decir, expresadas en desviaciones respecto de su propia media.

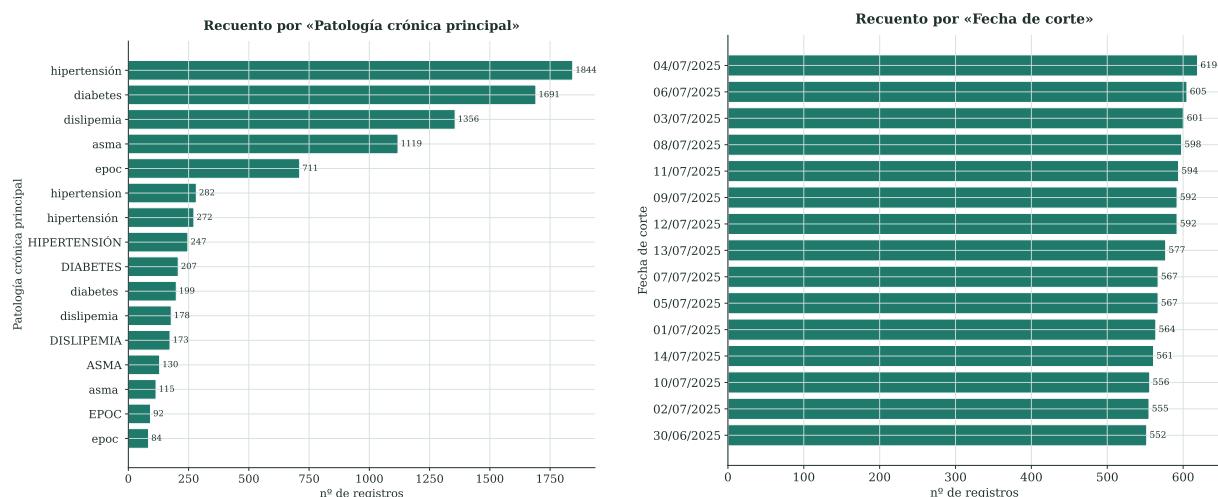
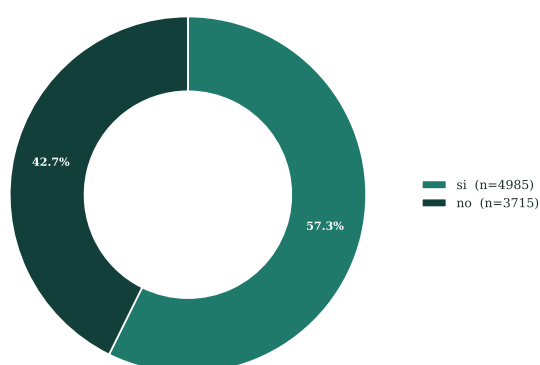


Figura 5. Recuento de registros por «Patología crónica principal» (izquierda) y por «Fecha de corte» (derecha).

Reparto por «Adherencia al tratamiento»



Reparto por «Vía de administración principal»

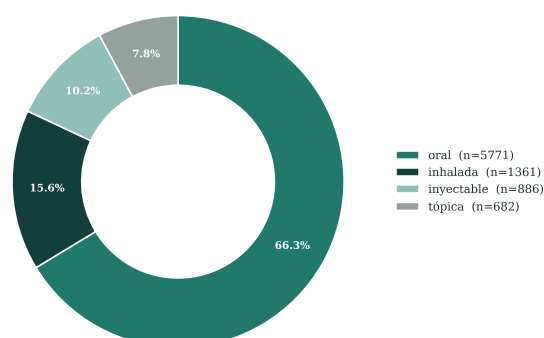


Figura 6. Reparto de registros por «Adherencia al tratamiento» (izquierda) y por «Vía de administración principal» (derecha).

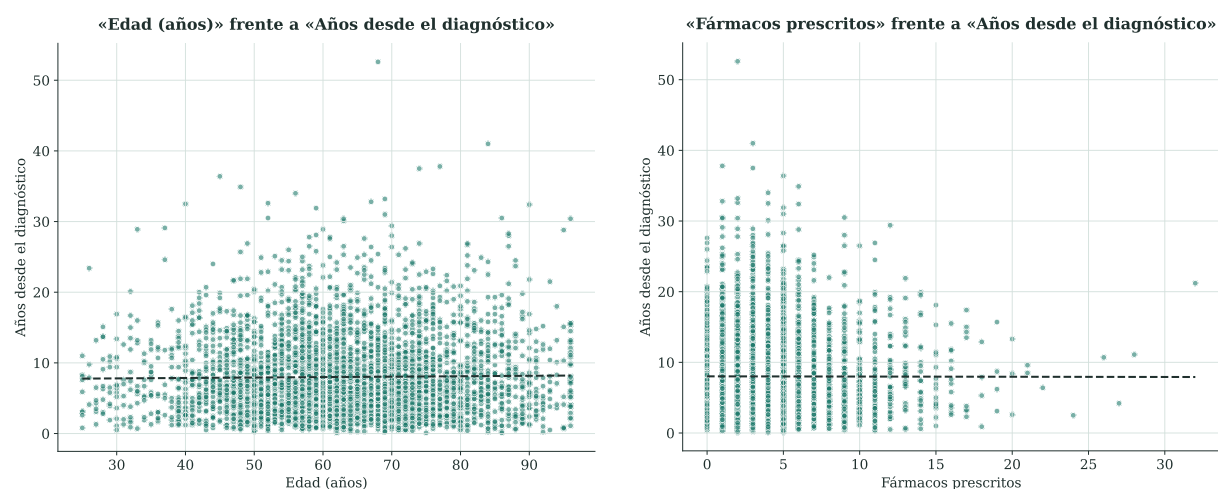


Figura 7. «Edad (años)» frente a «Años desde el diagnóstico» (izquierda) y «Fármacos prescritos» frente a «Años desde el diagnóstico» (derecha).

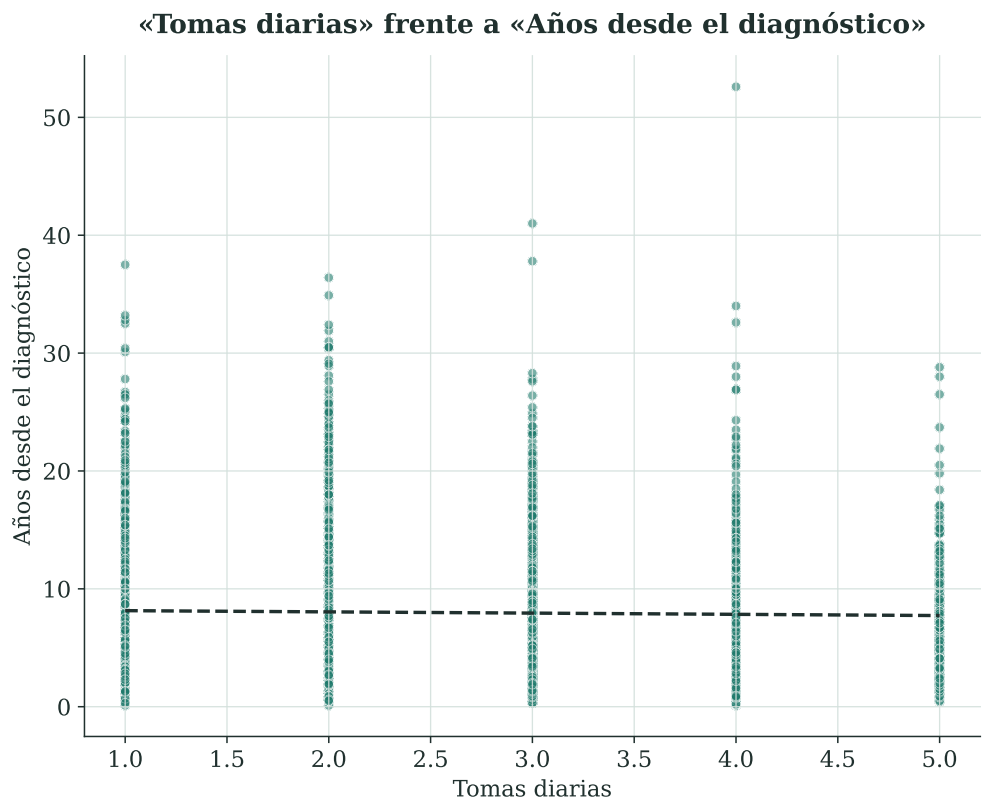


Figura 8. «Tomas diarias» frente a «Años desde el diagnóstico».

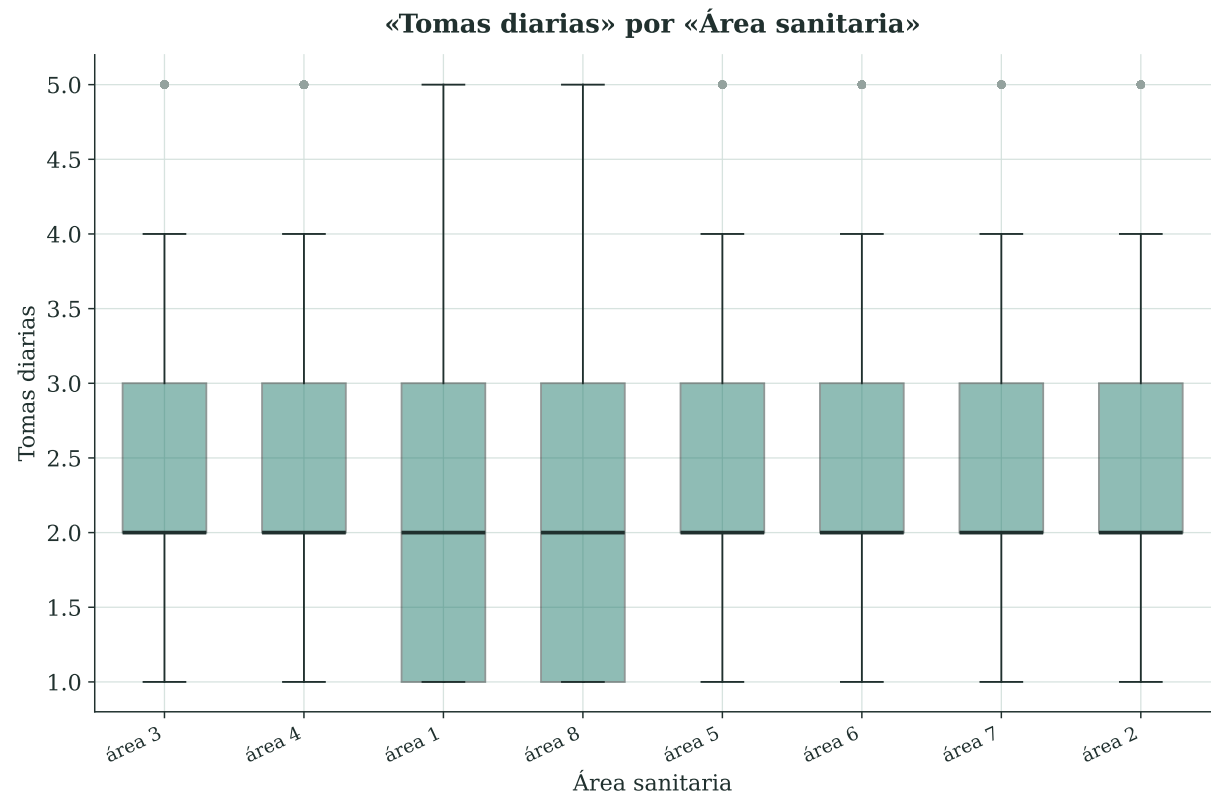


Figura 9. «Tomas diarias» desagregado por «Área sanitaria».

5 Posibles enriquecimientos del conjunto

Reflexión abierta para el analista

Más allá de los campos disponibles, conviene preguntarse qué otras fuentes de información mejorarían el conjunto y qué se ganaría con cada una. Primero, ¿qué información clínica de resultado, como el control de la cifra de tensión o de la hemoglobina glicosilada, validaría la medida de adherencia? Segundo, ¿qué datos de efectos adversos, como las notificaciones o los cambios de tratamiento, explicarían el abandono? Tercero, ¿qué variables de intervención, como las llamadas de seguimiento o los sistemas personalizados de dosificación, permitirían evaluar las medidas de apoyo? De todas ellas, ¿cuáles considera factibles de obtener respetando la normativa aplicable y cuáles meramente hipotéticas, y mediante qué código de tarjeta sanitaria las uniría al fichero actual?